วิชา
เหล่าทหารแพทย์

แผนกวิชาการเสนารักษ์
กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์
กรมแพทย์ทหารบก

หัวข้อบรรยาย

เหล่าทหารแพทย์

- การจัด พบ.
- ภารกิจ
- พันธกิจ
- หน่วยสายแพทย์ ทบ.
- การบริการทางการแพทย์
- หลักนิยมเหล่าทหารแพทย์

กรมแพทย์ทหารบก

อนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน
Conserve the Fighting Forces, Families and People

กรมแพทย์ทหารบก

การแบ่งมอบและฐานะ

- เป็น นขต.ทบ.
- เป็นกรมฝ่ายยุทธบริการ
- เป็นส่วนส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
- เป็นส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม

กองทัพบก

โครงสร้างการจัดกองทัพบก 2566

ส่วนบัญชาการ
- สำนักงานผู้บังคับบัญชา
- กรมฝ่ายยุทธบริการ
- กรมฝ่ายเสนาธิการ
- กรมฝ่ายกิจการพิเศษ
- สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม
- โรงเรียนนายร้อยฯ
- กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ศูนย์สงครามพิเศษ
- ศูนย์การบินทหารบก
- โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่าง ๆ

ส่วนภูมิภาค
- กองทัพภาคที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 11-19
- กองทัพภาคที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21-210
- กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 31-310
- กองทัพภาคที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 41-46

ส่วนกำลังรบ
- กองทัพภาคที่ 1
- กองทัพภาคที่ 2
- กองทัพภาคที่ 3
- กองทัพภาคที่ 4

ส่วนสนับสนุนการรบ
- กองพลทหารปืนใหญ่
- กองพลทหารช่าง
- กองพันทหารช่างที่ 51
- กรมทหารสื่อสารที่ 1
- กรมบิน
- กองร้อยวิทยาศาสตร์
- หน่วยข่าวกรองทางทหาร
- หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

ส่วนส่งกำลังบำรุง
- กรมการทหารช่าง
- กรมสรรพาวุธทหารบก
- กรมแพทย์ทหารบก
- กรมยุทธโยธาทหารบก
- กรมการสัตว์ทหารบก
- กรมการทหารสื่อสาร
- กรมพลาธิการทหารบก
- กรมขนส่งทหารบก
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ส่วนพัฒนาประเทศ
- กองพลทหารช่าง
- กองพลพัฒนา

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายงานประจำปี 2565
กองทัพบก

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ARMY MEDICAL FIELD SERVICE SCHOOL

กรมฝ่ายยุทธบริการ

- กรมการทหารช่าง
- กรมสรรพาวุธทหารบก
- กรมแพทย์ทหารบก
- กรมยุทธโยธาทหารบก
- กรมการสัตว์ทหารบก
- กรมการทหารสื่อสาร
- กรมพลาธิการทหารบก
- กรมขนส่งทหารบก
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

วิชาแหล่าทหารแพทย์

กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)

วิสัยทัศน์

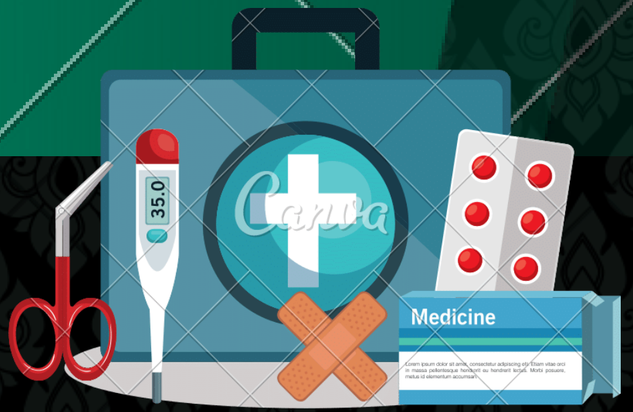
เป็นองค์กรด้านการแพทย์ทหาร ที่เป็นที่เชื่อมั่น
ของกองทัพ ประชาชน และภูมิภาค

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ แก่กำลังพล
ครอบครัว และประชาชน
ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ
และเวชกรรมป้องกัน
การบริการแพทย์ในที่ตั้ง
และการบริการแพทย์ในสนาม

วิชาเหล่าทหารแพทย์

กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)



ภารกิจ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การบริการพยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ เวชกรรมป้องกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล

2. กำหนดหลักนิยมและตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการ และสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารแพทย์ มีเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิชาเหล่าทหารแพทย์

กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)

ความรับผิดชอบของ พบ.

* คัดเลือกผู้ที่มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เข้ารับราชการ
* ป้องกัน ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพ
* การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ
* ส่งกำลัง และ ซบร. สป. 2 – 4 สาย พ.
* ฝึกศึกษาของกำลังพลเหล่า พ.

“การอนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน”

วิชาแหล่าทหารแพทย์

โครงสร้างการจัด พบ. (อฉก.3600) (นขต.บก.)

พบ.

อำนวยการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ	กิจการพิเศษ	ฝากการบังคับบัญชา
กกพ.พบ.	กวก.พบ.	รร.สร.พบ.	สวค.	นวป.
กยข.พบ.	กสวป.พบ.	กคพ.พบ.	ผธน.	ร้อย.รยพ.ทบ.
กกบ.พบ.	กทพ.พบ.	กบร.พบ.	สกง.	
กคง.พบ.		ผธก.		
		ผจห.		

วิชาแหล่าทหารแพทย์

โครงสร้างการจัด พบ. (อฉก.3600) (นขต.)

- พบ.
  - ศพม.
    - รพ.รร.6
    - สพธ.
    - วพม.
    - วพบ.
    - สวพท.
  - รพ.อ.ป.ร.
    - ร้อย.รยพ.ทบ.
    - พัน.นนส.ฯ
  - รพ.ค่ายสุรนารี

วิชาเหล่าทหารแพทย์

ประเภท หน่วยทหารแพทย์ใน ทบ.

มีรูปแบบตายตัว

เป็นอัตราโครงสร้างมาตรฐานพื้นฐานของหน่วยทหาร
เป็นเกณฑ์บรรจุกำลังในสถานการณ์ปกติและยามสงคราม

1. หน่วยทหารแพทย์ที่จัดหน่วยตาม อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.)

2. หน่วยทหารแพทย์ที่จัดหน่วยตาม อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.)

จัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจเฉพาะกิจ, ชั่วคราว

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือความต้องการของภารกิจ
ใช้บรรจุกำลังพลไม่เกินร้อยละที่กองทัพบกกำหนด

- อจย. คือโครงสร้างแบบมาตรฐาน
- อฉก. คือโครงสร้างที่ปรับเฉพาะกิจเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่หรือช่วงเวลา

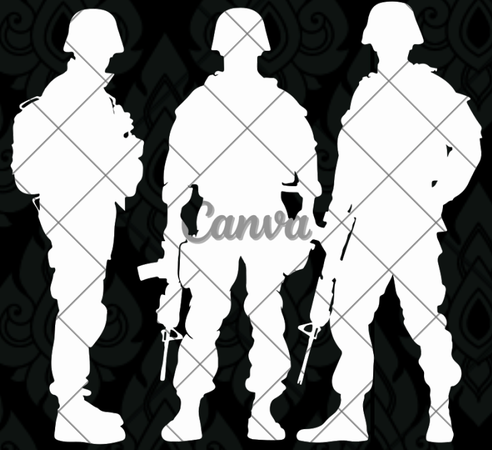
วิชาเหล่าทหารแพทย์

หน่วยทหารแพทย์ในกองทัพบก

1 หน่วยทหารแพทย์ที่จัดหน่วยตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.)

ประกอบด้วย

- หมู่ สร.ของ พัน.ป. และ กรม ป.
- ตอน สร.พัน.ม.(ลว.) (17 - 55 ก.)
- มว.สร.พัน. ร., พัน.ช. พัน.ม.(ก.), พัน.ม.(ลว.) (17 - 55 พ.)
- มว.สร.กรม ร., กรม ม., กรม รพศ.
- ตอน.สร.ร้อย บก.พล., ทภ.
- พัน.สร.พล.
- พัน.สร.บชร.
- ร้อย.รยพ.ทบ.
- นวป.ทบ.



รพ.ทบ.

สังกัด มทบ.(รพ.ค่าย)

- รพ. ขนาด 30 เตียง 8 แห่ง
- รพ. ขนาด 70 - 90 เตียง 16 แห่ง
- รพ. ขนาด 150 - 200 เตียง 6 แห่ง

วิชาเหล่าทหารแพทย์

หน่วยทหารแพทย์ในกองทัพบก

2 หน่วยทหารแพทย์ที่จัดหน่วยตาม อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.)

ประกอบด้วย

- โรงพยาบาล 7 แห่ง เป็นโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ คือ
  1) โรงพยาบาลของกรมแพทย์ทหารบก 3 แห่ง รพ.รร.6, รพ.อ.ป.ร. ,รพ.ค่ายสุรนารี
  2) รพ.ระดับกองทัพภาค 2 แห่ง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ, รพ.ค่ายวชิราวุธ
  3) รพ.ในส่วนการศึกษา 2 แห่ง รพ.รร.จปร. , รพ.ค่ายธนะรัชต์
- กองพยาบาล 2 แห่ง
- แผนกพยาบาล 1 แห่ง
- หมวดพยาบาล 14 แห่ง
- หน่วยตรวจโรค (ส่วนกลาง) 13 แห่ง
- หน่วยตรวจโรค (ส่วนภูมิภาค 5 แห่ง)
- หมู่.สร.ของหน่วยที่ใช่ อฉก. เช่น หมู่.สร.กรม สห.ฯลฯ

วิชาเหล่าทหารแพทย์ รพ.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.1 จำนวน 11 แห่ง

รพ.พระมงกุฎเกล้า
1.400 เตียง
นขต.ศพม. จว.ก.ท.

รพ.ค่ายสุรสีห์
200 เตียง มทบ.17 จว.ก.จ.

รพ.ค่ายภาณุรังษี
90 เตียง มทบ.16 จว.ร.บ.

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
30 เตียง มทบ.15 จว.พ.บ.

รพ.ค่ายธนะรัชต์
150 เตียง
สนับสนุนส่วนการศึกษา จว.ป.ข.

รพ.อานันทมหิดล
400 เตียง นขต.พบ. จว.ล.บ.

รพ.ค่ายอดิศร
90 เตียง มทบ.18 จว.ส.บ.

รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
150 เตียง สนับสนุนส่วนการศึกษา
จว.น.ย.

รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
90 เตียง มทบ.19 จว.ส.ก.

รพ.ค่ายจักรพงษ์
200 เตียง มทบ.12 จว.ป.จ.

รพ.ค่ายนวมินทราชินี
90 เตียง มทบ.14 จว.ช.บ.

วิชาเหล่าทหารแพทย์ รพ.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.2 จำนวน 10 แห่ง

รพ.ค่ายศรีสองรัก
30 เตียง มทบ.28 จว.ล.ย.

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
30 เตียง มทบ.23 จว.ข.ก.

รพ.ค่ายสุรนารี
400 เตียง นขต.พบ จว.น.ม.

รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
30 เตียง มทบ.26 จว.บ.ร.

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
90 เตียง มทบ.25 จว.ส.ร.

รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
30 เตียง มทบ.210 จว.น.พ.

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
90 เตียง มทบ.29 จว.ส.น.

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
200 เตียง มทบ.24 จว.อ.ด.

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
90 เตียง มทบ.27 จว.ร.อ.

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
200 เตียง มทบ.22 จว.อ.บ.

วิชาเหล่าทหารแพทย์ รพ.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.3 จำนวน 10 แห่ง

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
90 เตียง มทบ.37 จว.ช.ร.

รพ.ค่ายกาวิละ
90 เตียง มทบ.33 จว.ช.ม.

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
200 เตียง นขต. ทภ.3 จว.พ.ล.

รพ.ค่ายวชิรปราการ
90 เตียง มทบ.310 จว.ต.ก.

รพ.ค่ายจิรประวัติ
150 เตียง มทบ.31 จว.น.ว.

รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมฯ
30 เตียง มทบ.34 จว.พ.ย.

รพ.ค่ายสุริยพงษ์
30 เตียงมทบ.38 จว.น.น.

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
150 เตียง มทบ.32 จว.ล.ป.

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
90 เตียง มทบ.35 จว.อ.ต.

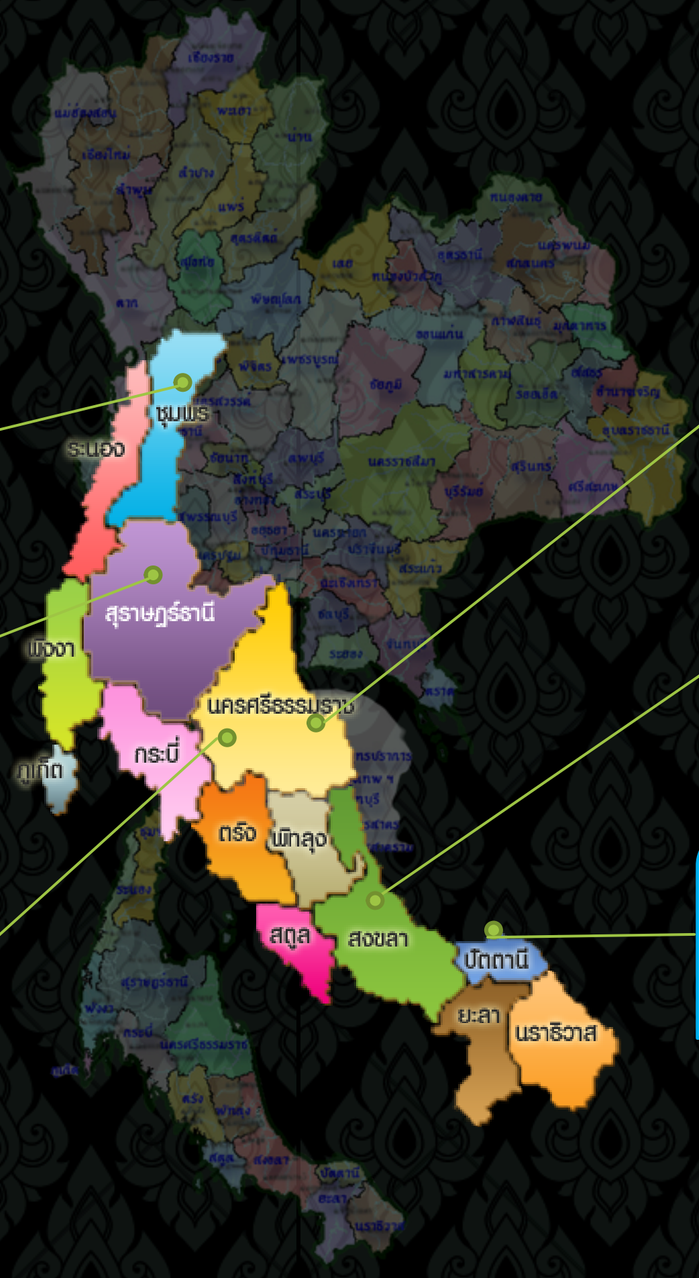
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
90 เตียง มทบ.36 จว.พ.ช.

วิชาเหล่าทหารแพทย์ รพ.ทบ.ในพื้นที่ ทภ.4 จำนวน 6 แห่ง

รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
90 เตียง มทบ.44 จว.ช.พ.

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
90 เตียง มทบ.45 จว.ส.ฎ.

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
90 เตียง มทบ.43 จว.น.ศ.



รพ.ค่ายวชิราวุ
150เตียง นขต./สังกัด
ทภ.4จว.น.ศ.

รพ.ค่ายเสนาณรงค์
90 เตียง มทบ.42 จว.ส.ข.

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
30เตียง มทบ.46 จว.ป.น.

วิชาเหล่าทหารแพทย์

ภารกิจของเหล่าทหารแพทย์

คือ

“การอนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน”

ทั้งในด้านการป้องกัน และการรักษาพยาบาล

วิชาเหล่าทหารแพทย์

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

เพื่อบรรลุภารกิจ เหล่า พ. มีพันธกิจสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

4

1 การเวชกรรมป้องกัน

ป้องกันการเกิดโรค การทำให้ชีวิตยืนยาว
และการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

2 การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ

การดูแลรักษาพยาบาลในหน่วยแพทย์ต่าง ๆ
ตั้งแต่รับตัวรักษาจนจำหน่าย

3 การส่งกำลัง สป. สาย พ.

สนับสนุน สป.สาย พ.
อย่างพอเพียงและทันเวลา

4 การบริการแพทย์อื่นๆ

- การทันตกรรม
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ธนาคารเลือด

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Preventive medicine)

คือ ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดโรค การทำให้ชีวิตยืนยาว และการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และประสิทธิภาพโดยรวมของบุคคล ชุมชน และประชากร

ความมุ่งหมาย การเวชกรรมป้องกัน

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- เพื่อป้องกันโรค
- เพื่อควบคุมการระบาดของโรค
- เพื่อลดงานด้านการรักษาพยาบาลให้น้อยลง
- เพื่อให้ความรู้

เป็นการดูแลสุขภาพแบบ "เชิงรุก" ที่เน้นการ ป้องกันก่อนที่โรคหรือความผิดปกติจะเกิดขึ้น

กำลังพลที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี หากไม่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัย ย่อมไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ แม้กองทัพจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีและ ทันสมัยเพียงใดก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามต้องการถ้า กำลังพลมีโรคภัยไข้เจ็บ

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Preventive medicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร (Military preventive medicine) หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติไป เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และ ส่งเสริมกำลังพล ในกองทัพบกให้ทหารทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะรับ การฝึก และปฏิบัติหน้าที่รบได้ทุกขณะ

- เพื่อควบคุมการระบาดของโรคภายในหน่วย
- ลดงานด้านการรักษาพยาบาลให้น้อยลง
- เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ด้านสุขศาสตร์ การสุขาภิบาลไปปรับปรุงแก้ไขครอบครัวและชุมชน

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ผบ.หน่วยทหาร
- ทหารทุกชั้นยศ
- ผู้บังคับหน่วยแพทย์
- นายทหารเวชกรรมป้องกัน
- หน่วยเวชกรรมป้องกัน กองทัพบก

แบ่งออกเป็น

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล
   และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)

การสุขาภิบาล คือกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงการจัดการของเสียจากมนุษย์ น้ำเสีย และขยะมูลฝอย รวมถึงการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การสุขาภิบาลยังครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เช่น การสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยต่อการบริโภค

สิ่งแวดล้อม

วิธีการที่กองทัพจะผดุงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอันสมบูรณ์ของทหาร และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เพื่อให้มีกำลังพลมีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือทำการสู้รบได้มากที่สุด

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล
   และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)

2.1 การป้องกันในระยะก่อนเกิดโรค ปฐมภูมิ (Premary Prevention)

เป็นการป้องกันที่เกิดขึ้น ก่อนที่โรคจะเริ่มแสดงอาการ ในระยะที่ร่างกายยังแข็งแรงดีแต่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การป้องกันในระดับนี้จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันไม่ให้คนได้รับเชื้อหรือปัจจัยเสี่ยง

ลักษณะการป้องกันระดับปฐมภูมิ

- ป้องกันก่อนโรค: เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บตั้งแต่แรก
- ส่งเสริมสุขภาพ: ส่งเสริมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการไม่สูบบุหรี่
- สร้างภูมิคุ้มกัน: ให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
- ปรับสภาพแวดล้อม: ทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อสุขภาพ เช่น ความสะอาดและอากาศถ่ายเทสะดวก

ตัวอย่าง

- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
- การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การส่งเสริมการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล
   และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)

2.2 การป้องกันในระยะเกิดโรค ทุติยภูมิ (Secondary Protection) คือ การตรวจหาและรักษาโรคหรือภาวะสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อหยุดยั้งหรือชะลอการลุกลามของโรค, ลดผลกระทบ, และป้องกันการแพร่กระจาย การป้องกันในระยะนี้จะมุ่งเน้นไปที่ การตรวจคัดกรอง (Screening) เช่น การตรวจแมมโมแกรมเพื่อหาเซลล์มะเร็งเต้านม หรือการตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึง การรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

หลักการและเป้าหมาย

- เป้าหมายหลัก: เพื่อตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกก่อนที่อาการจะแสดงออกมา หรือขณะที่โรคยังไม่รุนแรง และรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ
- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคแบบไม่แสดงอาการ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง
- กระบวนการ: การตรวจคัดกรอง: การตรวจร่างกายเป็นประจำ, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, การทดสอบต่างๆ เพื่อค้นหาโรค
- การวินิจฉัย: การวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบความผิดปกติ
- การรักษาทันที: การให้การรักษาอย่างรวดเร็วหลังจากวินิจฉัยได้

ตัวอย่าง

- การตรวจแมมโมแกรม:
- การตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด:
- การตรวจคัดกรองและติดตามผู้สัมผัสโรค:

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)

คือการปฏิบัติกิจวัตรเพื่อรักษาความสะอาดของร่างกายให้ห่างไกลจากเชื้อโรค และลดการแพร่กระจายของโรค ซึ่งรวมถึงการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม และการดูแลรักษาความสะอาดส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ยังรวมถึงการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ และการรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว และบริเวณที่พักอาศัย

การปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

- **การดูแลร่างกาย:** อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน และตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ
- **การล้างมือ:** ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
- **การแต่งกาย:** สวมเสื้อผ้าที่สะอาด
- **การรักษาสุขภาพ:** ปิดปากเมื่อไอหรือจาม และจัดการขยะให้ถูกวิธี
- **การดูแลสภาพแวดล้อม:** ทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัยเป็นประจำ เช่น การปัด กวาด เช็ด ถู และเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

ประโยชน์ของสุขอนามัยส่วนบุคคล

- **ป้องกันการติดเชื้อ:** ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ เช่น โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ หวัด และโควิด-19
- **ปกป้องผู้อื่น:** ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น
- **ส่งเสริมสุขภาพที่ดี:** การมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
- **สร้างความภาคภูมิใจ:** การดูแลตนเองให้สะอาดช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

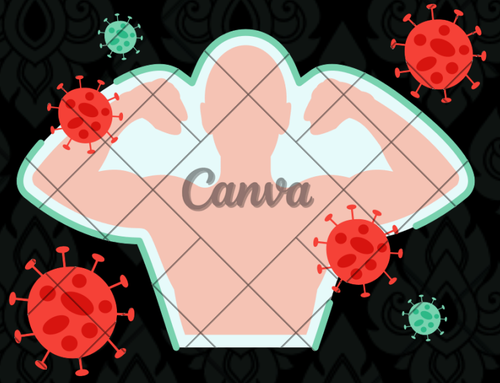
1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

เวชกรรมป้องกันทหาร

1. การสุขาภิบาล (Sanitation)
2. การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ (Disease & CommunicableDisease)
3. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล (PersonalHygiene)
4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

4. การให้ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity)

คือการที่ร่างกายสร้างกลไกเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค โดยสามารถแบ่งเป็น ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เช่น เมื่อหายจากการติดเชื้อ) และ ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการช่วยเหลือ เช่น การฉีดวัคซีน หรือการถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากมารดา นอกจากนี้ ยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นได้ ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันที่ดี



วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

- **รับประทานอาหารที่มีประโยชน์:** เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืช และสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
- **ออกกำลังกายสม่ำเสมอ:** การออกกำลังกายปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
- **นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ:** การนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟู
- **รักษาสุขภาพจิตใจ:** การทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียดหรือวิตกกังวล
- **หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง:** ไม่สูบบุหรี่และจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- **ควบคุมน้ำหนักตัว:** รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- **ตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามกำหนด:** ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำและฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

ยาเวชกรรมป้องกัน

1. ยาทาไล่แมลง
   - ในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย 2 หลอด/คน/เดือน (50-60 ซี.ซี.)
   - ในพื้นที่เฝ้าระวังต่อการติดเชื้อมาลาเรีย 1 หลอด/คน/เดือน (50-60 ซี.ซี.)
2. ผงเคมีกำจัดแมลง 1 ขวด (2 ออนซ์)/คน/เดือน
3. ผงโรยเท้า 1 ขวด (30 กรัม)/คน/เดือน
4. ยาเม็ดทำน้ำให้บริสุทธิ์ 48 เม็ด/คน/เดือน
5. ยาชุบมุ้ง 15 ซี.ซี./คน/เดือน

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

แนวทางปฏิบัติด้านเวชกรรมป้องกันระหว่างปฏิบัติราชการสนาม (Deployment)

การบริการน้ำ

ก. ความต้องการน้ำ วันหนึ่งทหารคนหนึ่งต้องการน้ำเฉลี่ยแล้วดังนี้

1) ในค่ายพักกึ่งถาวร 20-40 แกลลอน(90.6 – 181.2 ลิตร)

2) ในค่ายที่พักชั่วคราว 15 แกลลอน(67.95 ลิตร)

3) ในค่ายที่พักแรมหรือในการเดินทาง 2 แกลลอน (9.06 ลิตร)

4) ในระหว่างปฏิบัติการรบ

- เกณฑ์ปกติ 1 แกลลอน (4.53 ลิตร)
- เกณฑ์ต่ำ (ไม่นานเกิน 3 วัน) 1/2 แกลลอน (2.26 ลิตร)
- สำหรับสัตว์วันหนึ่งต้องการน้ำ 5-10 แกลลอน (22.65–45.3 ลิตร)

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

แนวทางปฏิบัติด้านเวชกรรมป้องกันระหว่างปฏิบัติราชการสนาม (Deployment)

ส้วม หลักปฏิบัติในการสร้างส้วม

-เมื่อเข้าที่พักต้องสร้างส้วมทันที แม้จะพักเพียงคืนเดียว

- ให้ส้วมอยู่ด้านใต้ลมของที่พัก
- มีจำนวนส้วม ร้อยละ 8 ของกำลังพล
- ส้วมต้องกันแมลงวันได้
- ส้วมควรอยู่ห่างจากโรงครัวอย่างน้อย 300 ฟุต ห่างจากที่พักและแหล่งน้ำอย่างน้อย 100 ฟุต ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับแหล่งน้ำ
- ต้องขุดร่องระบายน้ำไว้รอบส้วมและอย่าระบายไปสู่แหล่งน้ำ
- ไม่ควรขุดส้วมถึงระดับน้ำใต้ดิน
- ไม่ควรขุดส้วมในที่ดินเหนียว ควรขุดในดินที่น้ำซึมได้สะดวก
- ควรใช้ผ้ากระโจมหรือกิ่งไม้ใบกั้นฝาโดยรอบ ในค่ายพักกึ่งถาวรควรมีหลังคา
- ควรมีโคมไฟไว้ที่ส้วม นอกจากสถานการณ์ไม่อำนวย
- เมื่อระดับอุจจาระเหลือ 1 ฟุต จะเต็มหลุมหรือจะเคลื่อนย้ายต่อไปให้กลบส้วมด้วยดินพูนสูงจากระดับพื้นดิน 1 ½ ฟุต

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

แนวทางปฏิบัติด้านเวชกรรมป้องกันระหว่างปฏิบัติราชการสนาม (Deployment)

ที่ถ่ายปัสสาวะ

ก. ในการพักประจำ ชม. และ “พักนาน” กำหนดที่ให้ทหารถ่ายปัสสาวะ อย่าปล่อยให้ทหารถ่ายปัสสาวะตามใจชอบ

ข. ในการ “พักแรม” ไม่เกิน 3 วัน ให้ขุดร่องปัสสาวะยาว 10 ฟุต กว้าง 3 ฟุต ลึก 6 นิ้ว พรวนดินร่อง ให้หลวมๆ ลึกลงไปอีก 6 นิ้ว กองดินที่ขุดไว้รอบปากร่องเพื่อใช้กลบเมื่อจะเคลื่อนย้ายต่อไป ร่องแบบนี้ใช้ได้สำหรับทหาร 200 คน

ค. ในการ “พักแรม” เกิน 3 วัน ให้ใช้ที่ถ่ายปัสสาวะซึมโดยขุดหลุมขนาด 4 x 4 x 4 ฟุต แล้วใช้กรวดอิฐหรือ หินย่อยใส่ให้เต็มหลุม ใช้กระบอกไม้ไผ่หรือ กรวยโลหะฝังตามมุมทั้ง 4 ของหลุม ที่ถ่ายปัสสาวะแบบนี้ใช้ได้สำหรับทหาร ๒๐๐ คน

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน (Militarypreventivemedicine)

แนวทางปฏิบัติด้านเวชกรรมป้องกันระหว่างปฏิบัติราชการสนาม (Deployment)

ที่ล้างหน้าและที่อาบน้ำ

ก. ที่ล้างหน้าและที่อาบน้ำ
ข. สร้างที่ล้างหน้ายาว 10 ฟุต สำหรับทหาร 100 คน
ค. สร้างที่อาบน้ำอย่างน้อย 3 ที่ สำหรับทหาร 100 คน

โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร

ก. ให้ตั้งห่างจากส้วม ห่างกันอย่างน้อย 300 ฟุต
ข. ขุดหลุมทิ้งเศษอาหาร 1 หลุม ต่อทหาร 200 คน ขนาดกว้างด้านละ 4 ฟุต ลึก 4 ฟุต ใช้ดินกลบ หนาอย่างน้อย 2 นิ้ว ทุกวัน
ค. สร้างหลุมซึมสำหรับกำจัดน้ำล้างผัก อาหารและภาชนะเครื่องใช้
ง. กลบหลุมทิ้งสิ่งปฏิกูลให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

8. ระเบียบกองทัพบก

ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ

พ.ศ.2519

ตอนที่ 1

กล่าวโดยทั่วไป

ข้อ 1. ความมุ่งหมาย

เพื่อให้การรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในระเบียบเดียวกัน จึงกำหนดระเบียบนี้ขึ้นเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 2. ให้เรียกระเบียบนี้ว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.2519"

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบและคำสั่งดังต่อไปนี้

3.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ พ.ศ.2512

3.2 บรรดาระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ ของกองทัพบกที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4. คำจำกัดความ

ระเบียบกองทัพบก

ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม

พ.ศ.2514

ตอนที่ 1

กล่าวโดยทั่วไป

ข้อ 1 ความมุ่งหมาย เพื่อให้การรักษาพยาบาล และการส่งกลับในสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดระเบียบนี้ขึ้นไปเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 2 ให้เรียกระเบียบนี้ว่า " **ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาล และการส่งกลับในสนาม พ.ศ.2514** "

ข้อ 3 คำจำกัดความ

3.1 คนไข้ หมายถึง บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ ป่วย หรือ มีอาการผิดปกติ ทางร่างกาย และจิตใจ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

3.2 ทหาร หมายถึง นายทหาร นายสิบ พลทหาร นักเรียนทหาร และ ข้าราชการกลาโหม

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

การรักษาพยาบาล คือ การให้การดูแลรักษาพยาบาลในหน่วยแพทย์ต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่ห้วงระยะเวลาที่หน่วยแพทย์รับตัวไว้จนกระทั่งจำหน่าย ไปในที่สุด

ในสนามรบ ทหารจะได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่จุดที่ได้รับบาดเจ็บในแนวหน้า

ความมุ่งหมายของการรักษาพยาบาล

- ก็เพื่อที่จะ ส่งคืน ทหารป่วยเจ็บที่ได้รับการรักษาหายดีแล้ว กลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็ว
- หน่วยแพทย์ทุกระดับในเขตหน้า ต้องพิจารณาเปิดที่พยาบาลของตน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ทางการยุทธ เพื่อดำรงความคล่องตัวไว้

หลักการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บในสนาม

- อาการสาหัส ต้องใช้เวลารักษานานวัน ให้การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน รีบส่งกลับ
- อาการบาดเจ็บเล็กน้อย ให้การรักษาพยาบาลให้หายในเวลาสั้นที่สุด รีบส่งคืน (Return to Duty) ให้เร็วและมากที่สุด

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ

คือ กรรมวิธีการตรวจผู้ป่วยเจ็บ เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนให้ผู้ป่วยเจ็บได้ถูกส่งไปรับการรักษาพยาบาลยังหน่วยแพทย์ที่มีขีดความสามารถตามต้องการ

จุดมุ่งหมายของการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บก็เพื่อ

- การรักษาพยาบาล
- ส่งกลับ

ทุกขั้นตอนของที่ตั้งหน่วยแพทย์ จะต้องทำการคัดแยก ผป.เสมอ

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ เพื่อการรักษา 4 ประเภท

1. ประเภททันที/รอไม่ได้ (Immediate)
2. ประเภทรอได้ (Delayed)
3. ประเภทเล็กน้อย (Minimal)
4. ประเภทพอมีหวัง/คาดว่าถึงแก่กรรม (Expectant)

ลำดับการรักษาพยาบาล ในยามปกติ

1. ประเภททันที/รอไม่ได้ (Immediate)
2. ประเภทรอได้ (Delayed)
3. ประเภทเล็กน้อย (Minimal)
4. ประเภทพอมีหวัง/คาดว่าถึงแก่กรรม (Expectant)

ลำดับการรักษาพยาบาล ในยามสงคราม

1. ประเภทเล็กน้อย (Minimal)
2. ประเภททันที/รอไม่ได้ (Immediate)
3. ประเภทรอได้ (Delayed)
4. ประเภทพอมีหวัง/คาดว่าถึงแก่กรรม (Expectant)

วิชาเหล่าทหารแพทย์

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

การส่งกลับ

การส่งกลับทางการแพทย์ หรือ การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ คือ การเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเจ็บจากจุดบาดเจ็บ (สนามรบ) หรือจากหน่วยแพทย์ที่อยู่ ข้างหน้า มายังหน่วยแพทย์ที่อยู่ ข้างหลัง

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ เพื่อ จัดลำดับความเร่งด่วนใน การส่งกลับ แบ่งได้ 4 ประเภท

1. ด่วนที่สุด (Urgent) ส่งกลับทันทีไม่เกิน 2 ชม. (นับจากที่ได้รับบาดเจ็บ)
2. ด่วน (Priority) ส่งด่วน แต่รอได้ไม่เกิน 4 ชม.
3. ธรรมดา (Routine) รอได้นานเกิน 4 ชม.
4. ด่วนยุทธการ (Tactical Urgent) ผบ.หน่วยทางยุทธวิธีรับผิดชอบ

หน่วยแพทย์ที่อยู่ข้างหลังหนึ่งระดับ จะต้องรับผิดชอบการส่งกลับ ผู้ป่วยเจ็บ ให้กับ หน่วยแพทย์ที่อยู่ข้างหน้า

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

วิธีการส่งกลับ

1. การส่งกลับทางพื้นดิน

2. การส่งกลับทางอากาศ
   - เร่งด่วน สาหัส
   - ลมฟ้าอากาศ สถานการณ์ทางยุทธวิธี
   - จากแนวหน้าร้องขอการส่งกลับผ่านทางสายการบังคับบัญชา

3. การส่งกลับทางน้ำ

งานสายแพทย์ที่ “ยากลำบากที่สุด” ในสนามรบ คือ....“การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ”

1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาล
   และการส่งกลับทางการแพทย์
3. การส่งกำลังสาย พ.
4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

2. การรักษาพยาบาล และการส่งกลับทางการแพทย์

การส่งกลับ

ความล่าช้าของการส่งกลับ

1. การกระทำของข้าศึก
2. การขนส่งที่ไม่อาจหาได้
3. การรักษาพยาบาลระหว่างทาง
4. ระบบการติดต่อสื่อสาร
5. สภาพภูมิประเทศ ถนนและลมฟ้าอากาศ
6. ความจำเป็นทางการรบ
7. การลำเลียงโดยใช้กำลังคน

งานสายแพทย์ที่ “ยากลำบากที่สุด” ในสนามรบ คือ.... “การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ”

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

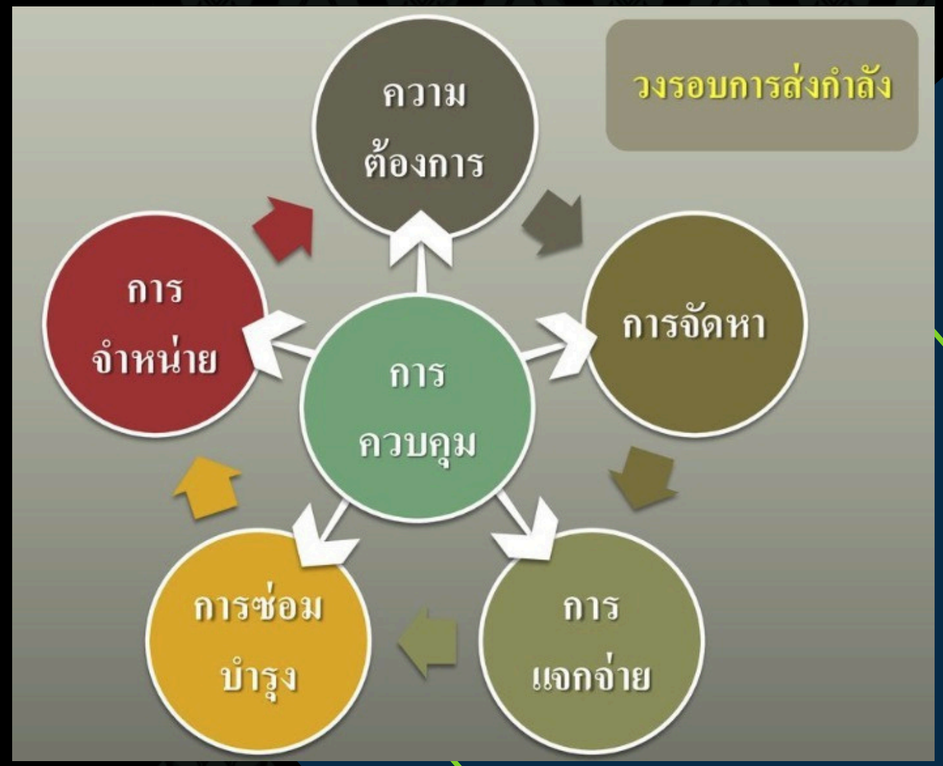
3. การส่งกำลังสาย พ.

การส่งกำลัง สป. แบ่งออกเป็น

1. สป.ทั่วไป เบิกตามสายการส่งกำลัง

2. สป.สาย พ.

- ยามปกติ เบิกตามสายการส่งกำลัง เหมือน สป.ทั่วไป
- ในสนามรบ เบิกตามสายการส่งกลับ



เอาของไปให้ เอาคนไข้กลับไปรักษา

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

3. การส่งกำลังสาย พ. ในเวลาปกติ ตามสายการส่งกำลัง

สป.ถาวร

พื้นที่ กทม. และปริมณฑล และ ทภ.1 : พบ. → หน่วยใช้

พื้นที่ ทภ. 2 – 4 : พบ. → บชร. → หน่วยใช้

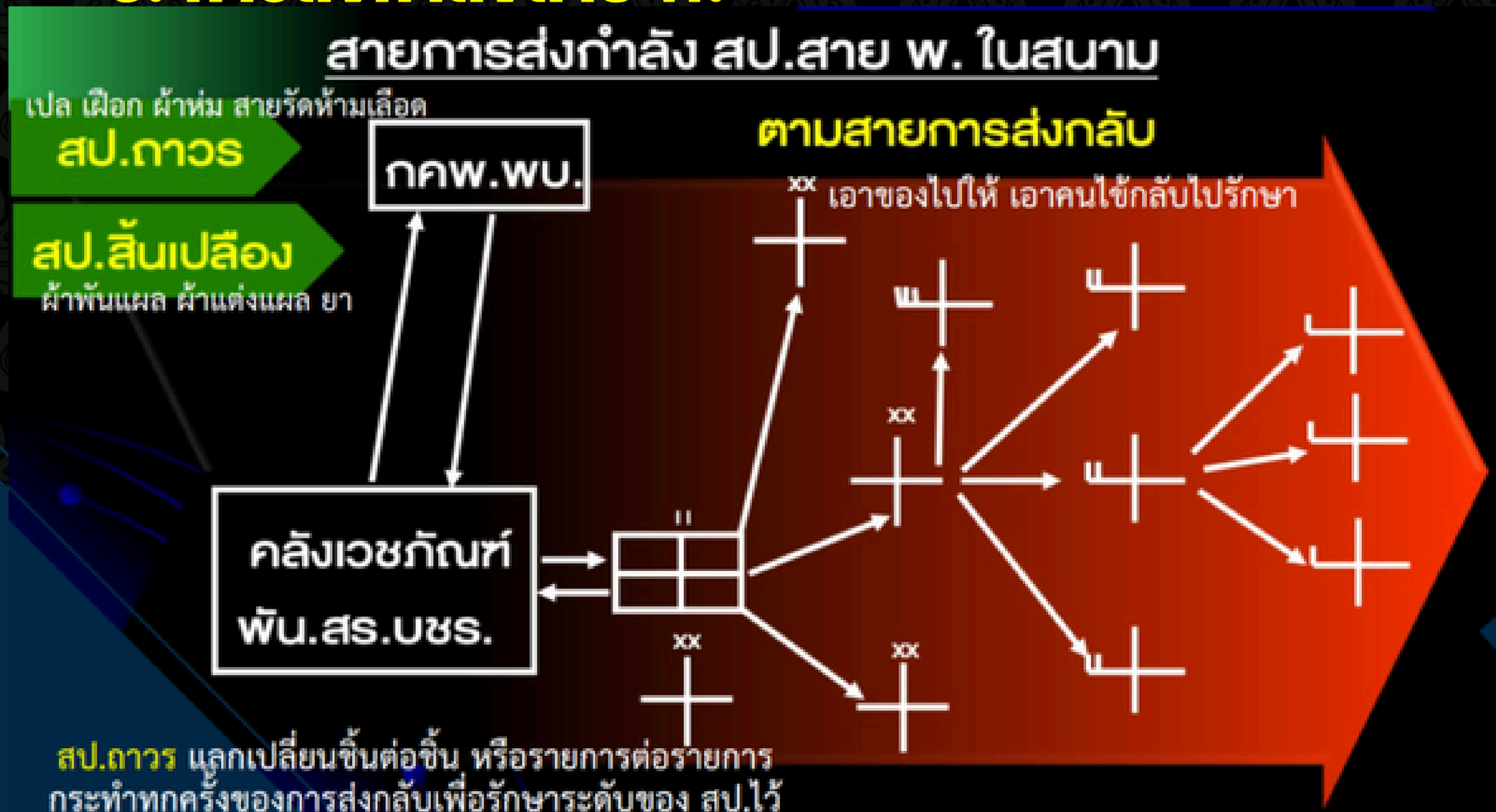
สป.สิ้นเปลือง

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล : พบ. → หน่วยใช้

พื้นที่ ทภ. 1 – 4 : พบ. → รพ.ทบ. → หน่วยใช้

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

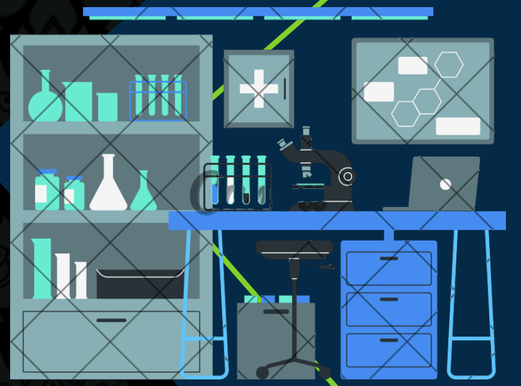
3. การส่งกำลังสาย พ.



พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

4. การบริการแพทย์อื่น ๆ

- การทันตกรรม
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ธนาคารเลือด



วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ.

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

เวลาปกติ

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในเวลาปกติ
พ.ศ.2519

- เปิดที่ตรวจโรค
- หน่วยตรวจโรค
- รพ.ทบ.

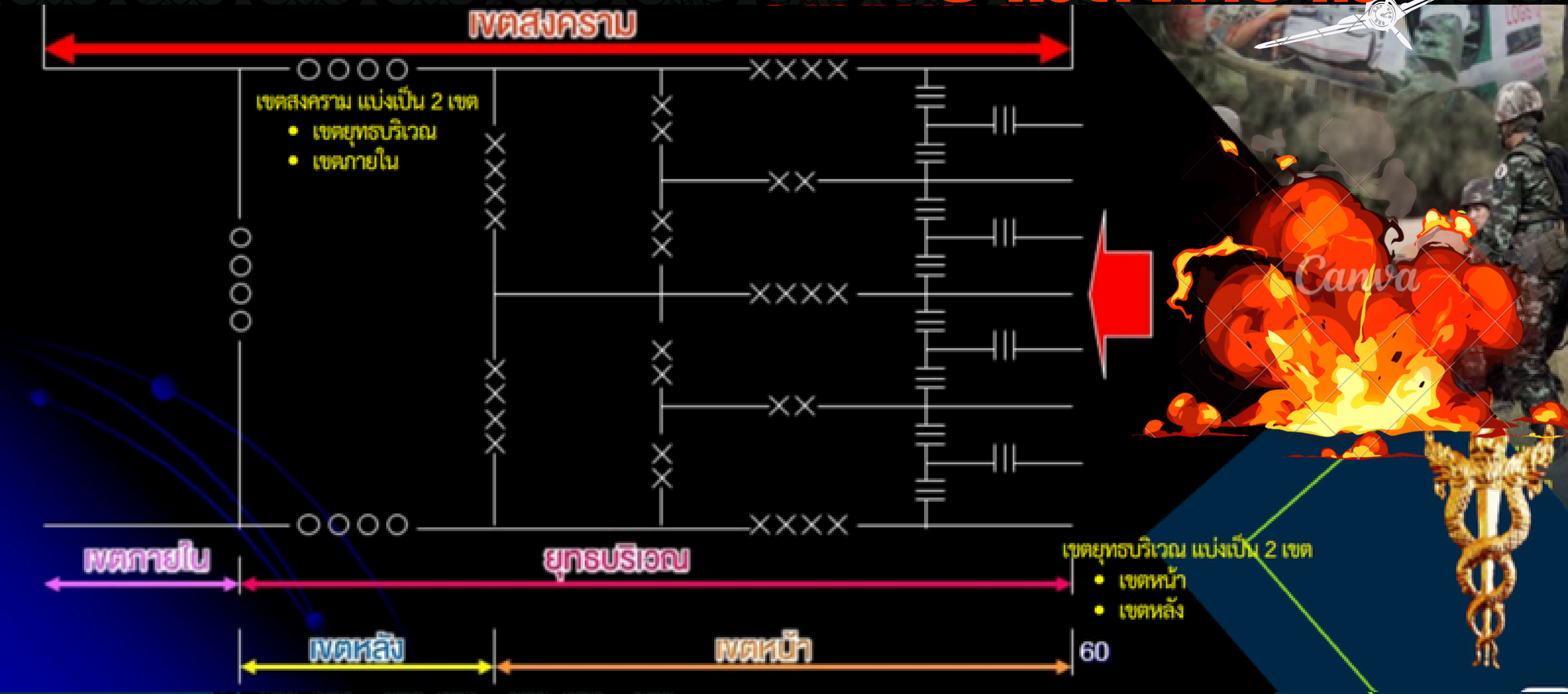
ในสนาม

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม
พ.ศ.2514

- จัดตั้งที่พยาบาลกองพัน
- จัดตั้งที่พยาบาลกองพล
- จัดตั้งที่พยาบาลกองทัพ
- เขตหลัง/เขตภายใน

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม



วิชาแหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

เขตสงคราม

เขตภายใน

5. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตภายใน

รพ.ทบ. (นขต.พบ.)
- รพ.รร.6
- รพ.อ.ป.ร.
- รพ.ค่ายสุรนารี
- รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทอ.
- รพ.องค์การทหารผ่านศึก
- รพ.พลเรือนที่กำหนด

เฉพาะทาง พักฟื้น อวัยวะเทียม

เขตยุทธบริเวณ

เขตหลัง

4. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง

รพ.มทบ./รพ.พลเรือนในพื้นที่

เฉพาะทาง

เขตหน้า

1. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
ขนาดหน่วยตั้งแต่ มว.สร. ลงมา
ฉุกเฉิน TCCC

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
พัน.สร.พล ช่วยชีวิตขั้นแรก

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
พัน.สร.บชร. รักษาช่วยชีวิต

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

ลำดับการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม ทบ.

4-5
เยอหลัง/ภายใน

ที่เฉพาะ/พักฟื้น

18 คัน

มว.รยพ.

30 วัน

พัน.สร.มชร.

ช่วยชีวิต

ร้อย.สร.สน.
ชุดศัลยกรรมสนาม
ชุดรักษาพยาบาล

3.ระดับ ทภ.

เร่งด่วน

มว.สร.

ร้อย.สสช.พัน.ร.

10 คัน

ตอนส่งกลับ

3 คัน

10 วัน

20 วัน

ร้อย.สร.

ช่วยชีวิตขั้นแรก

พัน.สร.
กรม สน.พล.ร.

2.ระดับกองทัพล

TCCC พบ.

ช่วยเหลือตนเอง
SELF AID

ช่วยเหลือโดยเพื่อน
BUDDY AID

ส.พยาบาลกองร้อย
AID MAN

ลาก/ อุ้ม/ เปล

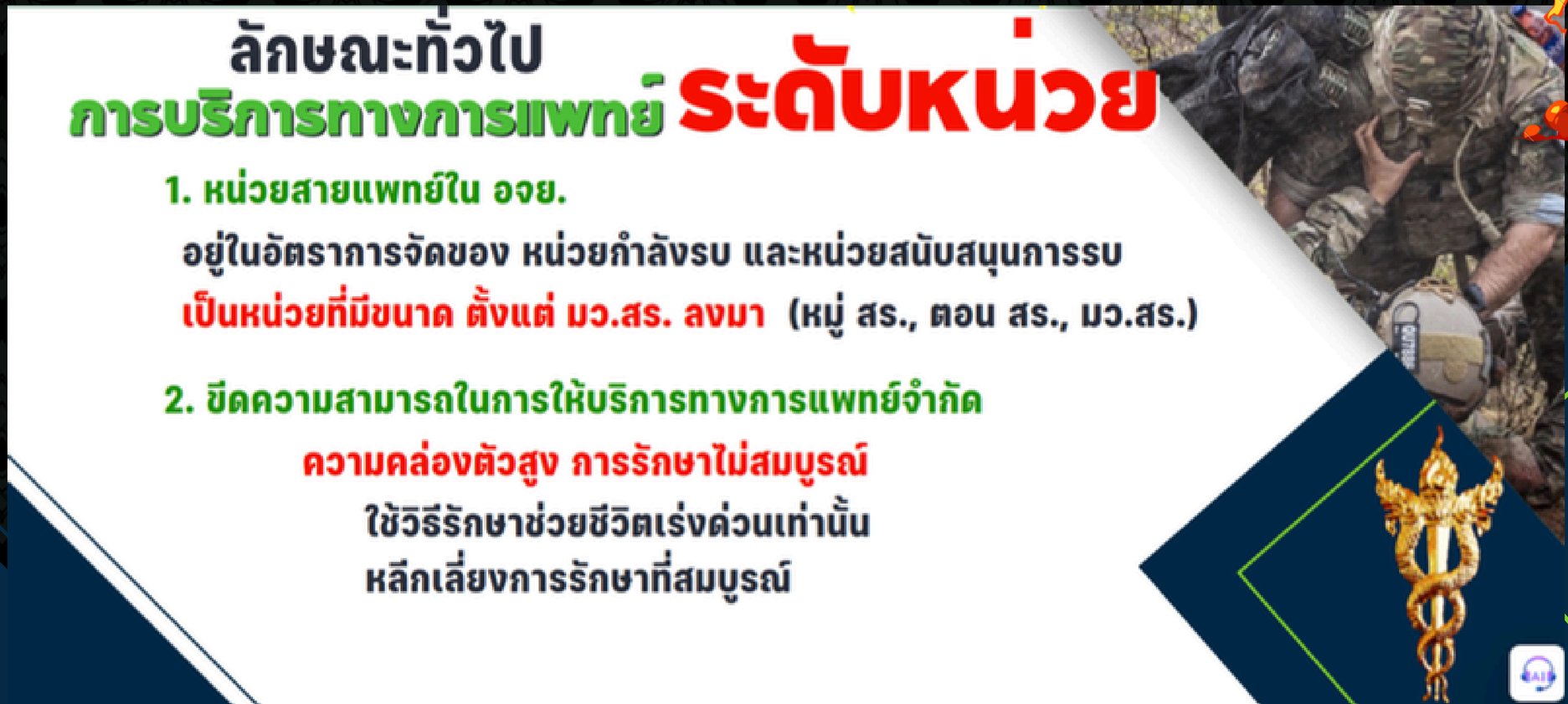
1.ระดับหน่วย

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

1. การบริการแพทย์ระดับหน่วย (Unit Level Medical Service)

เป็นการบริการทางการแพทย์ระดับที่ 1 ของระบบการ รักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ ในยุทธบริเวณ ให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ ที่ปฏิบัติการในสนาม



วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

1. การบริการแพทย์ระดับหน่วย (Unit Level Medical Service)

การบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วย

ใช้หลักการดูแลผู้ป่วยเจ็บเชิงยุทธวิธี
(Tactical Combat Cascualty Care:TCCC)

โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ

1. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเสียชีวิตที่ป้องกันได้
2. ป้องกันไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

M-A-R-C-H P-A-W-S (Pain)

คู่มือสอน TCCC
รออัพเดต

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

1. การบริการแพทย์ระดับหน่วย (Unit Level Medical Service)

หน้าที่ นอกสถานการณ์รบ

1. เปิดที่ตรวจโรค ตามความจำเป็น
2. ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน ด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะ
3. ฝึกสอนกำลังพลของ พัน.ร. เรื่อง การปฐมพยาบาล สุขศาสตร์ส่วนบุคคล การสุขาภิบาล วิธีการป้องกันการบาดเจ็บและบาดแผล

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

1. การบริการแพทย์ระดับหน่วย (Unit Level Medical Service)

หน้าที่ ในสถานการณ์รบ

มีงานเพิ่มจากงานนอกสถานการณ์รบ คือ

1. จัดนายสิบพยาบาลกองร้อย ไปสมทบหน่วยรบตามอัตรามูลฐาน 4 นาย ต่อ 1 ร้อย.อวบ.(1 นาย ต่อ 1 มว.ปล. และอีก 1 นาย ที่ ทก.ร้อย.อวบ.) หรือตามความจำเป็น

2. จัดตั้งที่พยาบาลกองพันทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเพิ่มเติมต่อจากนายสิบพยาบาลกองร้อย

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการแพทย์ระดับหน่วย (Unit Level Medical Service)

หน้าที่ ในสถานการณ์รบ

3. ทำการส่งกลับ ผป.เจ็บจากสนามรบ มายังที่พยาบาลกองพันและประสานการส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพล

4. ให้บริการทางการแพทย์ทางท้ายรถ(Tailgate Medical Service) เมื่อหน่วยดำเนินกลยุทธเคลื่อนที่เร็ว

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

เป็นการบริการทางการแพทย์ระดับที่ 2 ของระบบการ รักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ ในยุทธบริเวณ ให้บริการทางการแพทย์ระดับกองพล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการทางการแพทย์ทั้งปวงในพื้นที่ส่วนหน้า และส่วนหลังของกองพล

หน่วยที่ให้การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล **ระดับกองพล**

คือ พัน.สร.พล.ร./ม.

ขีดความสามารถ

- จัดตั้งที่พยาบาลกองพลได้ 4 แห่ง สนับสนุน กรม ร. 3 แห่ง และในพื้นที่ส่วนหลังกองพล 1 แห่ง
- ตรวจรักษาทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม (รังสีกรรม)
- รับผู้ป่วยเจ็บได้ 80 คน และอาจขยายในกรณีจำเป็นได้ 120 คน
- ส่งกำลัง สป.สาย พ.
- ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ขั้นหน่วย
- เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง 100%

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

การจัดหน่วย
พัน.สร.พล.ร./ม.

พล.ร./พล.ม.

กรมสนับสนุน

พัน.สร.

บก.และ ร้อย. บก.

ร้อย.สร.สน. XX 1 แห่ง

ร้อย.สร. หน้า XX 3 แห่ง

ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล แก่หน่วยในพื้นที่ของกองพล โดย

- การรักษาพยาล
- การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
- การ ซบร.เครื่อง พ. ขั้นหน่วย
- การส่งกำลัง สป.2-4 สาย พ.

ขีดความสามารถ

1. จัดตั้งดำเนินการที่พยาบาลกองพลได้ 4 แห่ง (พื้นที่ส่วนหลัง กองพล 1 แห่ง พื้นที่กรม 3 แห่ง)
2. ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม (จังสีกรรม)
3. ส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
4. ส่งกำลัง สป.สาย.พ. ให้หน่วยแพทย์ต่าง ๆ ในกองพล
5. ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ชั้นหน่วย
6. เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง 100 %

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

การจัดหน่วย

อัตราเต็ม ๑๓๘ นาย (น.๑๑, ส.๓๔, พลฯ ๕๓)

หมายเหตุ อัตราการจัด ร้อย.สร.สนับสนุน พัน.สร.กรม สน.พล.ม. และ พล.ร.(ก.) ๘-๓๘ ม. (๒๕ ม.ค.๒๔) เหมือนกับการจัด ร้อย.สร.สนับสนุน พัน.สร.กรม สน.พล.ร. ตาม อจย.๘-๓๘ (๒๕ ม.ค.๒๔)

การแบ่งมอบ

- จัดเป็น หน่วยในอัตรา ของ พัน.สร.
- จำนวน 1 ร้อย.สร.สน. / 1 พัน.สร.

ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล แก่หน่วย
ต่าง ๆ ใน พื้นที่ส่วนหลัง ของกองพล

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

อัตราเต็ม ๑๕๖ นาย (น.๑๑, ส.๘๑, พลฯ ๖๔)

หมายเหตุ อัตราการจัด ร้อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ม. และ พล.ร.(ก.) ตาม อจย.๘-๓๗ ม. (๒๕ ม.ค.๒๔)
ที่แตกต่างจากอัตราการจัด ร้อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร. ตาม อจย.๘-๓๗ (๒๕ ม.ค.๒๔)
คือ **มว.ส่งกลับ** ไม่มี**ตอนเปล** อัตรากำลังพลจึงน้อยกว่า ซึ่งมีอัตรากำลังพลดังนี้.-

อัตราเต็ม ๑๒๗ นาย (น.๑๐, ส.๗๗, พลฯ ๔๐)

การแบ่งมอบ

- จัดเป็น หน่วยในอัตรา ของ พัน.สร.
- จำนวน 3 ร้อย.สร.สน. / 1 พัน.สร.

ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล
สนับสนุนเป็นพื้นที่ ในพื้นที่ กรม ร.

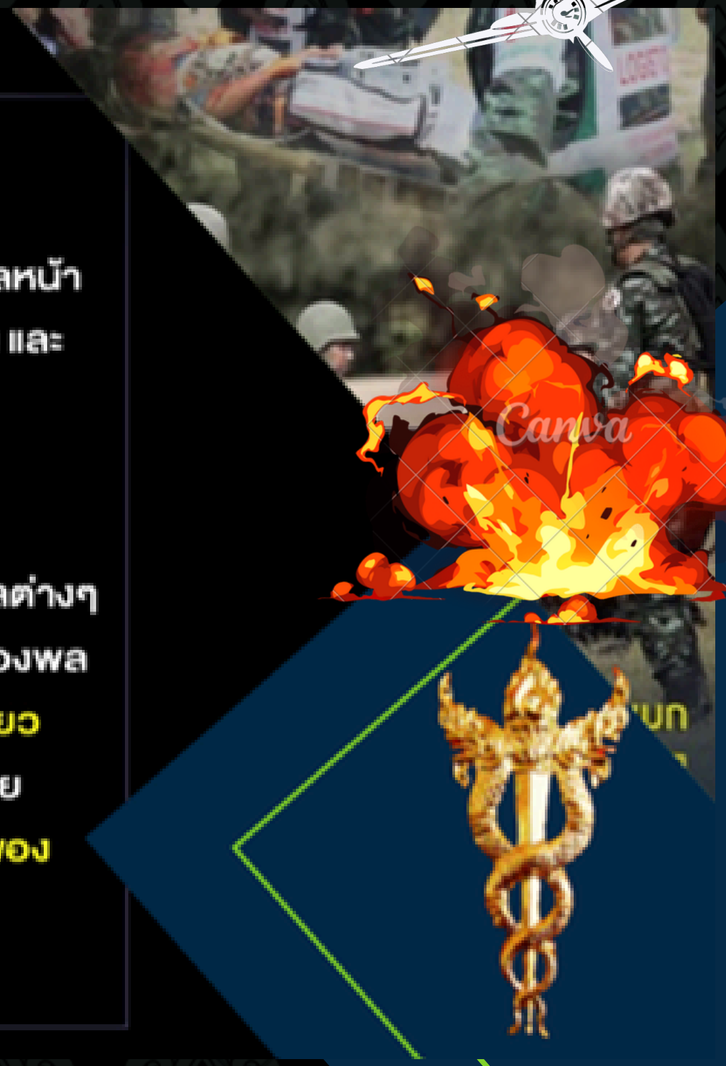
วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

สรุป ความแตกต่างของ ร้อย.สร.สน. กับ ร้อย.สร.

ร้อย สร.สน.	ร้อย สร.
ขีดความสามารถ	ขีดความสามารถ
1. จัดตั้งและดำเนินการที่พยาบาลกองพลได้ 1 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยเจ็บได้ 80 คน และอาจขยายในกรณีจำเป็นได้ 120 คน	1. จัดตั้งและดำเนินการที่พยาบาลกองพลหน้าได้ 1 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยเจ็บได้ 80 คน และอาจขยายราวในกรณีจำเป็นได้ 120 คน
2. ทำการตรวจโรคทางรังสีกรรม และตรวจรักษาโรคทั้งทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และทันตกรรม	2. ทำการตรวจรักษาทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และ ทันตกรรม
3. ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล มายังที่พยาบาลกองพล คนไข้นอน 24 คน นั่ง 48 คน ใน 1 เที่ยว	3. ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรมทหารราบ มายังที่พยาบาลกองพลหน้า คนไข้นอน 40 คน นั่ง 80 คน ใน 1 เที่ยว
4. ทำการส่งกำลังและขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล	4. ทำการส่งกำลังและขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่างๆ ในพื้นที่ของกรมทหารราบ
5. เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %	5. เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %



วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

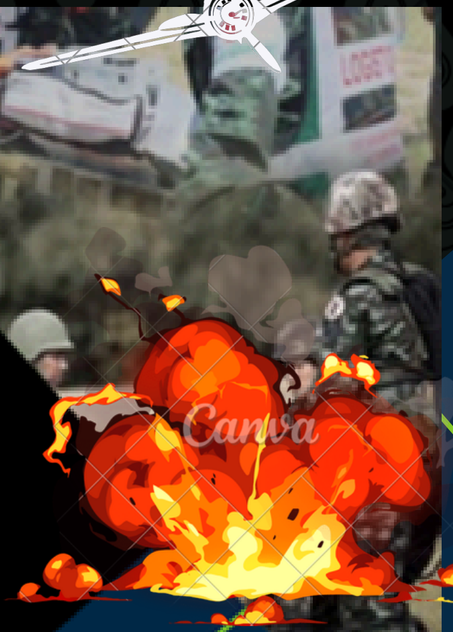
สรุป ความแตกต่างของ ร้อย.สร.สน. กับ ร้อย.สร.

ร้อย สร.สน.

- ไม่มีพลวิทยุ และวิทยุในอัตรา (ใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกับ ทก.พัน.สร.)
- ไม่มีนายสิบสูทกรรมและชุดสูทภัณฑ์ในอัตรา (ได้รับการเลี้ยงดูจาก ร้อย.บก.พัน.สร.)
- มีรถยนต์พยาบาล 6 คัน

ร้อย สร.

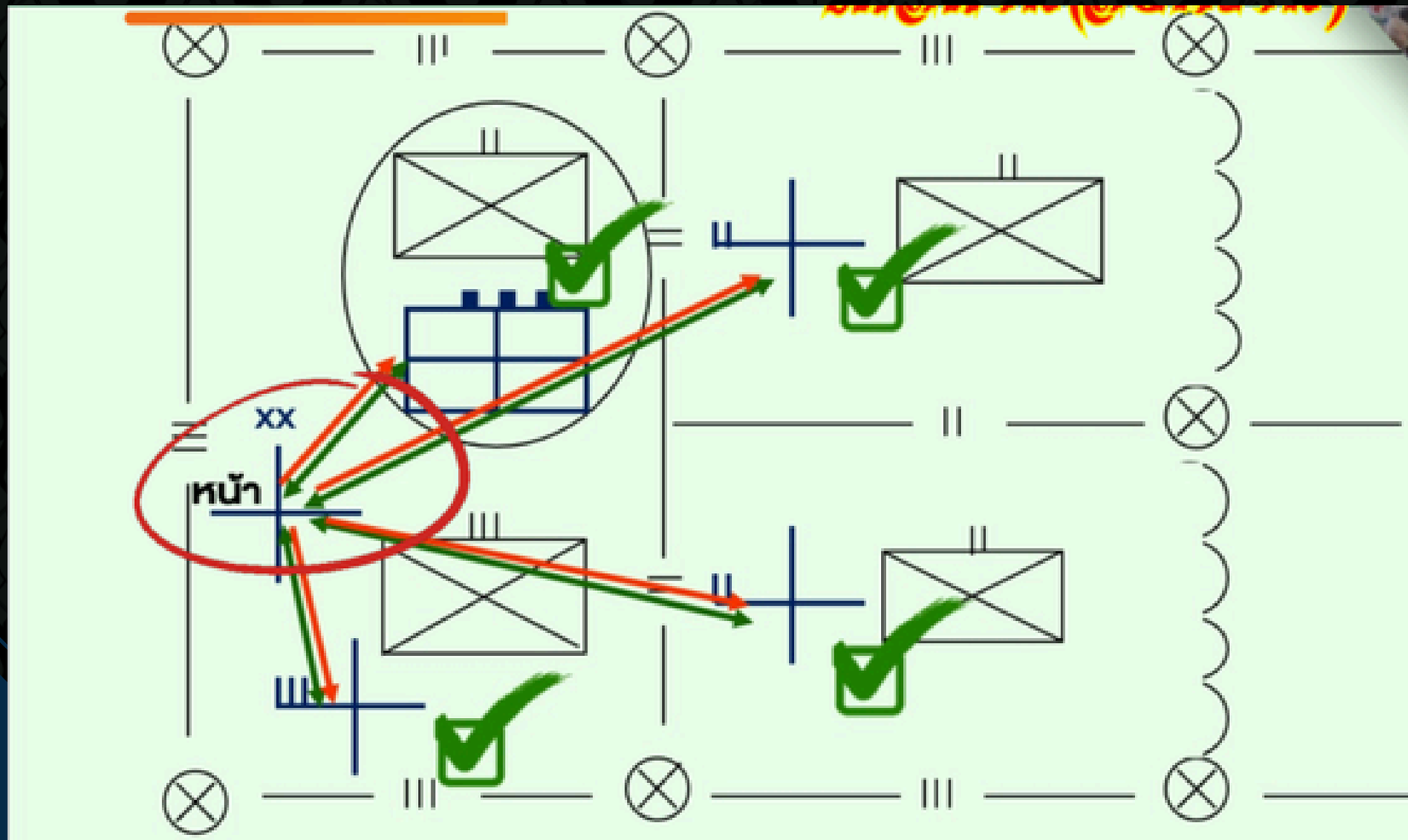
- มีพลวิทยุ และวิทยุอยู่ในอัตรา
- มีนายสิบสูทกรรม และชุดสูทภัณฑ์ในอัตรา
- มีรถยนต์พยาบาล 10 คัน



วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล



การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล ในพื้นที่ กรม ร.

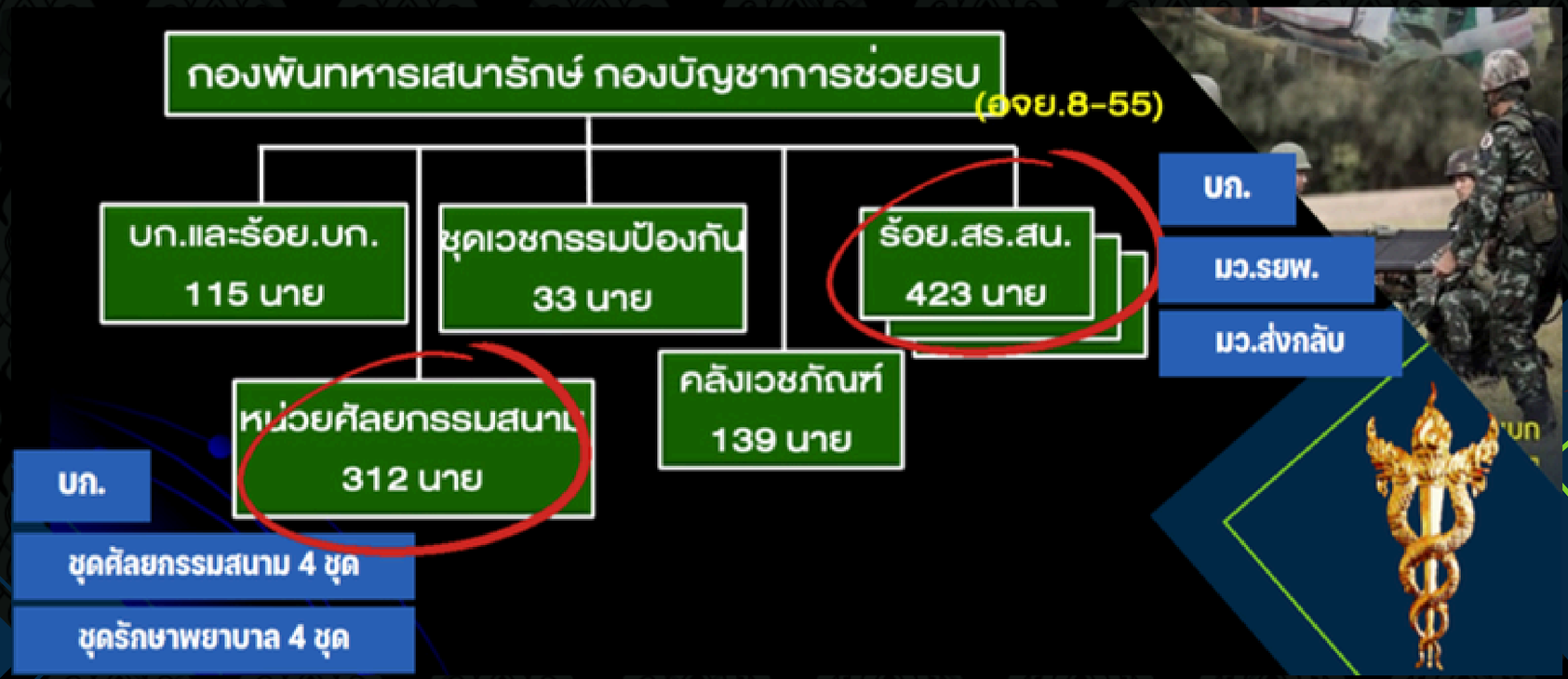
วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค

เป็นการบริการทางแพทย์ระดับที่ 3 ของระบบการรักษาพยาบาล และการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ ในยุทธบริเวณ ให้บริการทางการแพทย์แบบพื้นที่แก่หน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ของกองทัพทั้งหมด โดยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บที่ส่งกลับจากบริการแพทย์ระดับกองพล

กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ



วิชาแหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค

กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ

ภารกิจ

* จัดบริการเสนารักษ์ระดับกองทัพภาค
* เพิ่มเติมขีดความสามารถให้หน่วยเสนารักษ์ต่าง ๆ ใน ระดับกองพล
* จัดชุดศัลยกรรมสนามสนับสนุนหน่วยในแนวหน้า
* จัดบริการ เวชกรรมป้องกันในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
* ส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย พ. ในพื้นที่

ขีดความสามารถ

* ส่งกลับ ผป.จากที่พยาบาลกองพลมายังหน่วยรักษาพยาบาลในพื้นที่ หรือ รพ.ทภ. และเพิ่มเติมสนับสนุนการส่งกลับจาก ที่พยาบาลหน่วยข้างหน้า ประเภท ผป.นอนได้ 216 คนหรือ ผป.นั่งได้ 432 คน ต่อ เที่ยว ในอัตราเต็ม

* ส่งกำลัง สป.สาย พ.ทุกชนิดให้ รพ.และหน่วย เสนารักษ์ที่ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ

* ซ่อมบำรุง สป.สาย พ. ได้ถึงขั้น 4 อย่างจำกัด

* สนับสนุนและบริการ กำกับดูแลด้านเวชกรรมป้องกัน แก่หน่วยทหารและกำลังพลในพื้นที่

* จัดชุดศัลยกรรมสนาม และชุดรักษาพยาบาล ปฏิบัติงาน รพ.ในพื้นที่ ยามปกติ

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค

กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ

ขีดความสามารถ

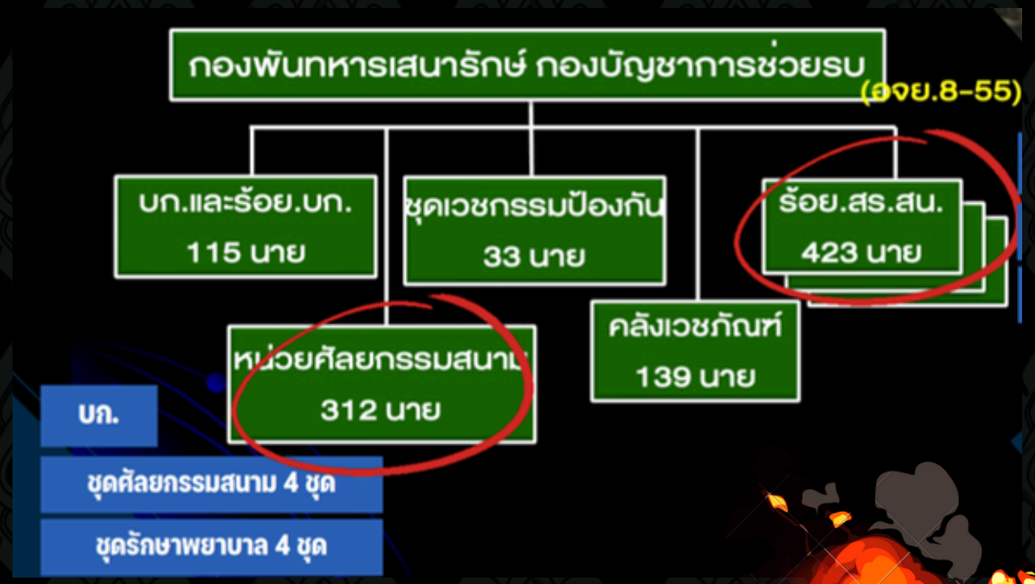
1.จัดชุดศัลยกรรมสนามและชุดรักษาพยาบาลสมทบ ร้อย สร.สน.พัน.สร.บชร.ฯ หรือสนับสนุนหน่วยเสนารักษ์ในเขตหน้าได้ 4 ชุด ในอัตราเต็ม 2 ชุดในอัตราลด

2. ผ่าตัดเร่งด่วนและดูแลผู้ป่วยเจ็บหลังผ่าตัดได้ในห้วงเวลาจำกัด

3. ให้การรักษาพยาบาลทางศัลยกรรมและอายุรกรรมทั่วไปได้ชุดละ 80 เตียง ขยาย 100 เตียง ในห้วงเวลาจำกัด

4. ยามปกติ ชุดศัลยกรรมสนามและชุดรักษาพยาบาลปฏิบัติงานใน รพ. ในพื้นที่

5. ต้องได้รับการบริการด้านการเลี้ยงดูจากหน่วยที่รับการสนับสนุน

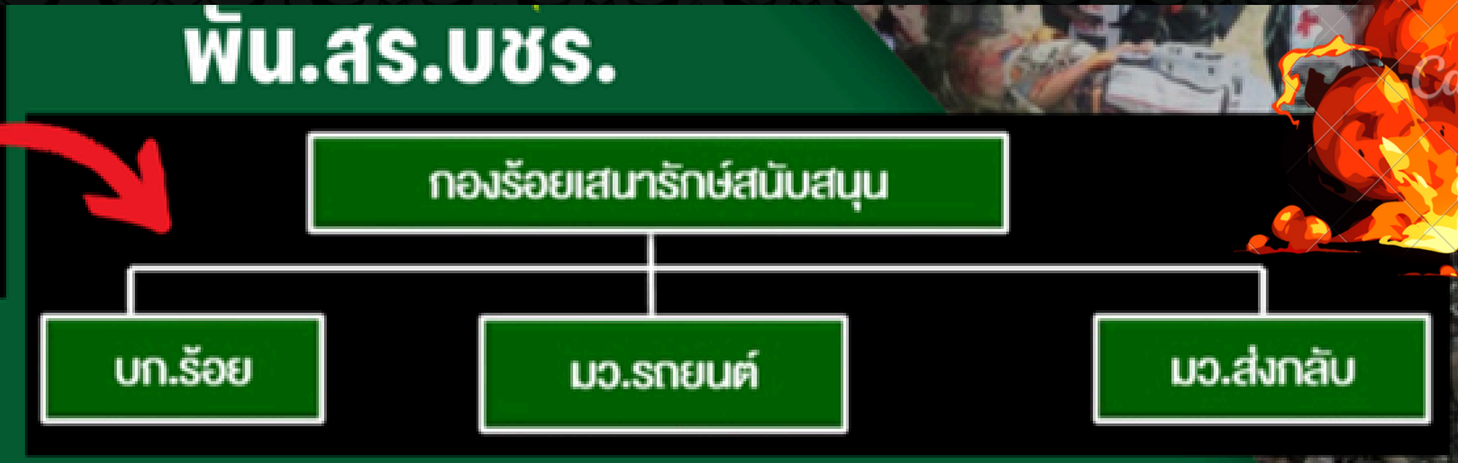


วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

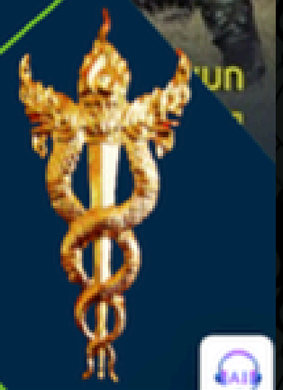
3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค

กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ



ขีดความสามารถ

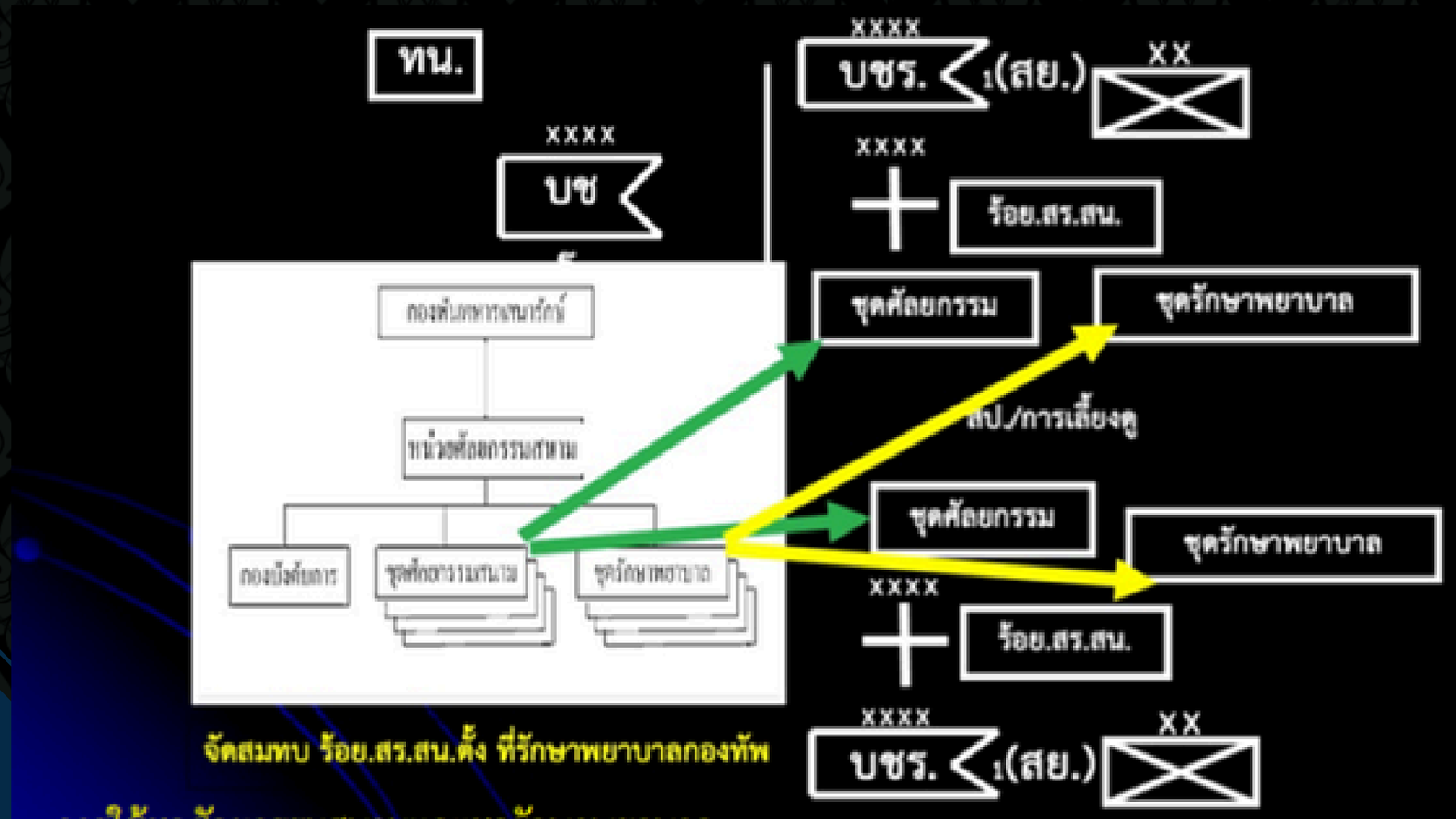
1. ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บโดยรถยนต์พยาบาล นอนเปลได้ 72 คน นั่ง 144 คน/เที่ยว จากที่พยาบาลกองพลไปยังหน่วยรักษาพยาบาลในพื้นที่ หรือ รพ.ระดับกองทัพภาค
2. เพิ่มเติมสนับสนุนรถยนต์พยาบาล และ/หรือเปลให้กับหน่วยเสนารักษ์ในแนวหน้าตามที่ร้องขอ
3. สนับสนุนการเบิก-รับ สป.สาย พ. ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ในแนวหน้าตามที่ร้องขอ
4. สนับสนุนงานด้านธุรการ ส่งกำลัง ซ่อมบำรุงเวชภัณฑ์ การเลี้ยงดูชุดศัลยกรรมสนาม ชุดรักษาพยาบาล ที่มาปฏิบัติการในพื้นที่



วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค



จัดสมทบ ร้อย.สร.สน.ตั้ง ที่รักษาพยาบาลกองทัพ

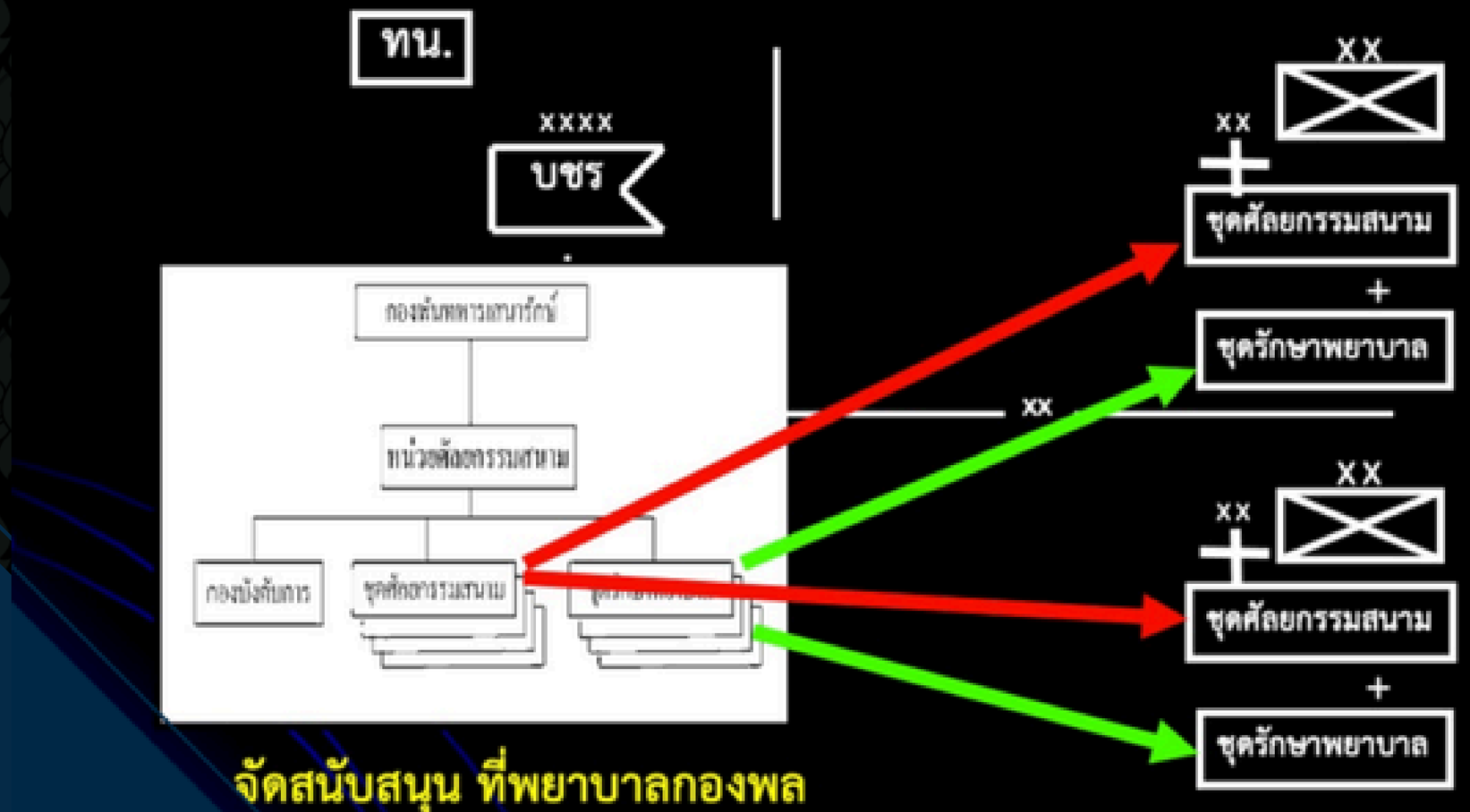
การใช้ชุดศัลยกรรมสนามและชุดรักษาพยาบาล

โดย จัดตั้งที่พยาบาลกองทัพภาค

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค



จัดสนับสนุน ที่พยาบาลกองพล

โดยจัดไปสนับสนุนที่พยาบาลกองพล

วิชาเหล่าทหารแพทย์

การให้การบริการทางการแพทย์ของ ทบ. ยามสงคราม

4-5. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง/เขตภายใน

4

การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง
เป็นการบริการทางแพทย์ระดับที่ 4 ระดับสุดท้ายของระบบการรักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในยุทธบริเวณ ให้การรักษาเพื่อช่วยชีวิต การรักษาที่เฉพาะ การรักษาที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

5

การบริการทางการแพทย์ระดับเขตภายใน
เป็นการบริการทางแพทย์ระดับที่ 5 รักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอวัยวะเทียม

การบริการทางการแพทย์ในยามสงคราม

หลักนิยมเหล่าทหารแพทย์

6 ประการ

1. หลักความต่อเนื่อง
2. หลักการควบคุม
3. หลักความใกล้ชิด
4. หลักความอ่อนตัว
5. หลักความคล่องตัว
6. หลักความสอดคล้อง

หลักนิยมแหล่าทหารแพทย์

ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง

1 หลักความต่อเนื่อง (Continuity)

"ดูแลไม่ให้ขาดตอน ตั้งแต่จุดบาดเจ็บจนถึงที่พยาบาล"

ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการรักษา

โดยไม่มีการหยุดชะงักระหว่างการส่งกลับ

การส่งมอบข้อมูลผู้ป่วยผ่านบัตร พ.ส.1 ต้องครบถ้วน

เพื่อให้หมอหรือพยาบาลในระดับต่อไปรักษาต่อได้ทันที

หลักนิยมแหล่าทหารแพทย์

ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง

2 หลักการควบคุม (Control)

"บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด"

ต้องมีการกำกับดูแลและบริหารกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเวชภัณฑ์สายแพทย์ให้กระจายไปยังจุดที่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดในสนามรบ

หลักนิยมเหล่าทหารแพทย์

ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง

3 หลักความใกล้ชิด (Proximity)

"อยู่ใกล้จุดบาดเจ็บ แต่ต้องปลอดภัยพอที่จะทำงานได้"

หน่วยแพทย์ต้องตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยรบหลักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ (Golden Hour) แต่ในขณะเดียวกันที่ตั้งนั้นต้องไม่อยู่ในจุดที่อันตรายเกินไปจนไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้

หลักนิยมเหล่าทหารแพทย์

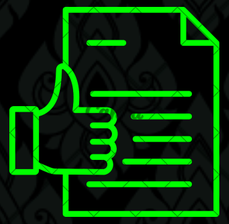
ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง

4 หลักความอ่อนตัว (Flexibility)

"ปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์"

สถานการณ์ในสนามรบเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แผนของสายแพทย์ต้องไม่ตายตัว เช่น หากเส้นทางส่งกลับหลักถูกตัดขาด ต้องมีแผนสำรอง หรือหากมีการสูญเสียจำนวนมาก ต้องสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยให้รองรับสถานการณ์นั้นได้ทันที

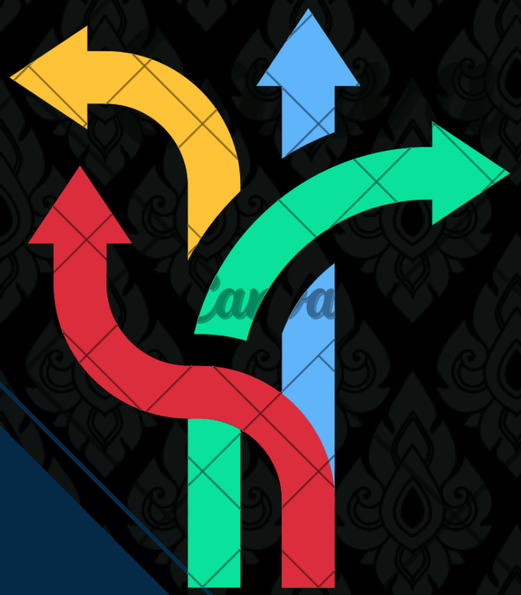
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง สมดุล



หลักนิยมแหล่าทหารแพทย์

5 หลักความคล่องตัว (Mobility)

"ต้องเคลื่อนย้ายได้เร็วเท่ากับหน่วยที่ไปสนับสนุน"



หน่วยแพทย์ต้องมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองได้รวดเร็วพอๆ กับหน่วยรบที่ไปสนับสนุน หากหน่วยรบเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หน่วยแพทย์ต้องเก็บกู้และเคลื่อนย้ายตามไปได้ทัน เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระหรืออยู่ห่างจากจุดที่ต้องการความช่วยเหลือมากเกินไป

หลักนิยมเหล่าทหารแพทย์

ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง

6 หลักความสอดคล้อง (Conformity)

“ถูกต้อง ตามเวลา และสถานที่ โดยไม่ขัดต่อการดำเนินกลยุทธ”

แผนทางการแพทย์ต้องสอดรับกับแผนการยุทธของหน่วยรบหลัก (หน่วยรบจะรุก จะรับ หรือจะถอนตัว สายแพทย์ต้องรู้และวางแผนรองรับให้ตรงกัน) หากหน่วยรบขยับไปทางไหน หน่วยแพทย์ต้องไปในทิศทางนั้นเพื่อให้การสนับสนุนไม่ขาดตอน

ภารกิจ
อนุรักษ์กำลังรบ
ครอบครัว และประชาชน
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ARMY MEDICAL FIELD SERVICE SCHOOL
6
หลักนิยม
ต่อเนื่อง
ควบคุม
ใกล้ชิด
อ่อนตัว
คล่องตัว
สอดคล้อง
4
พันธกิจ
1 การเวชกรรมป้องกัน
2 การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ
3 การส่งกำลังสาย พ.
4 การบริการแพทย์อื่น ๆ
การบริการ ทางการแพทย์ ใน ทบ.
ในยามสงคราม
รพ.พบ.
รพ.มทบ.
เขตภายใน เขตหลัง
พัน.สร.บชร.
ระดับกองทัพ
พัน.สร.พล.
ระดับกองพล
หมู,ตอน,มว.
ระดับหน่วย
ในยามปกติ
เปิดที่ตรวจโรค
หน่วยตรวจโรค
รพ.ทบ.
ประเภท หน่วย พ. ใน ทบ.
1 หน่วยแบบ อจย.
2 หน่วยแบบ อฉก..

Thank you

ตึก...ยังรู้พัง

สตางค์...ยังรู้หมด

แต่ “ไมตรี” อันสวยสด

ไม่มีหมด...เหมือนสตางค์